REDTIBIN

Decitabina para perfusión 50 mg/vial

COMPOSICIÓN

Cada vial contiene:

50 mg de decitabina (polvo liofilizado)

Excipientes: Fosfato monobásico de potasio, hidróxido de sodio, agua para inyección, Nitrógeno (Proceso de ayuda)

Descripción del producto:

La decitabina para inyección 50 mg/vial es un polvo liofilizado estéril para reconstitución. El producto se envasa en un vial de vidrio tubular de tipo I USP incoloro de 20 ml, y con sello *flip-off* de aluminio color rojo de 20 mm.

INFORMACIÓN CLÍNICA

Indicaciones

Tratamiento de pacientes adultos con síndromes mielodisplasicos (SMD) de riesgo intermedio- 1 y 2 y de alto riesgo, no candidatos a trasplante de médula ósea o a quimioterapia intensiva. Tratamiento de pacientes adultos de 65 y más años con leucemia mieloide aguda (LMA) de novo o secundaria quienes no son candidatos para quimioterapia de inducción estándar de reciente diagnóstico, de acuerdo con la clasificación de la OMS.

Posología y método de administración

Decitabina debe ser administrado bajo la supervisión de médicos experimentados en el tratamiento de agentes quimioterapéuticos.

Síndrome Mielodisplásico (SMD)

Hay 2 regímenes recomendados para la administración de Decitabina. Con cualquiera de los dos se recomienda que los pacientes sean tratados por un mínimo de 4 ciclos; sin embargo, una remisión parcial o completa puede tardar más de 4 ciclos para ser obtenido.

Se deben realizar recuentos sanguíneos completos y recuentos de plaquetas, según sea necesario para controlar la respuesta y la toxicidad, pero como mínimo, antes de cada ciclo. Se deben obtener análisis químicos del hígado y la creatinina sérica antes de iniciar el tratamiento.

Régimen de Tratamiento – Opción 1

Decitabina se administra a una dosis de 15 mg / m^2 mediante infusión intravenosa continua durante 3 horas repetida cada 8 horas durante 3 días. Este ciclo debe repetirse cada 6 semanas. Los pacientes pueden medicarse previamente con un tratamiento antiemético estándar.

Si la recuperación hematológica (ANC ≥ 1,000/µL y plaquetas ≥ 50,000/µL) de un ciclo de tratamiento previo con Decitabina requiere más de 6 semanas, entonces el siguiente ciclo de tratamiento con Decitabina debe retrasarse y la dosificación se debe reducir temporalmente siguiendo este algoritmo:

- Recuperación que requiere más de 6 semanas, pero menos de 8 semanas. La dosis de decitabina se retrasará hasta 2 semanas y la dosis se reducirá temporalmente a 11 mg/m^2 cada 8 horas (33 mg/m^2/día, 99 mg/m^2/ciclo) al reiniciar el tratamiento.

- Recuperación que requiere más de 8, pero menos de 10 semanas: el paciente debe ser evaluado para la progresión de la enfermedad (mediante aspirados medulares); en ausencia de progresión, la dosis de Decitabina se debe demorar hasta 2 semanas más y la dosis se reduce a 11 mg/m^2 cada 8 horas (33 mg/m^2/día, 99 mg/m^2/ciclo) al reiniciar el tratamiento, luego se mantiene o se aumenta en ciclos posteriores según lo indicado clínicamente.

Régimen de Tratamiento – Opción 2

La decitabina se administra a una dosis de 20 mg/m^2 mediante infusión intravenosa continua durante 1 hora repetida diariamente durante 5 días. Este ciclo debe repetirse cada 4 semanas. Los pacientes pueden medicarse previamente con un tratamiento antiemético estándar.

Si la mielosupresión está presente, los ciclos de tratamiento posteriores de Decitabina se deben retrasar hasta que haya una recuperación hematológica (ANC ≥ 1,000/µL de plaquetas ≥ 50,000/µL).

Pacientes con Toxicidad No Hematológica

Después del primer ciclo de tratamiento con decitabina, si se presenta alguna de las siguientes toxicidades no hematológicas, no se debe reiniciar el tratamiento con decitabina hasta que se resuelva la toxicidad: 1) creatinina sérica ≥ 2 mg/dL; 2) SGPT, bilirrubina total ≥ 2 veces ULN; 3) y la infección activa o no controlada.

Leucemia mieloide aguda (LMA)

En un ciclo de tratamiento, decitabina se administra en una dosis de 20 mg/m^2 de superficie corporal mediante perfusión intravenosa durante 1 hora al día durante 5 días consecutivos (es decir, un total de 5 dosis por ciclo de tratamiento). La dosis diaria total no debe exceder los 20 mg/m^2 y la dosis total por ciclo de tratamiento no podrá ser mayor de 100 mg/m^2. Si se omite una dosis, el tratamiento debe reanudarse lo antes posible. El ciclo se repetirá cada 4 semanas, en función de la respuesta clínica del paciente y de la toxicidad observada. Se recomienda tratar a los pacientes durante un mínimo de 4 ciclos; sin embargo, se puede tardar más de 4 ciclos en conseguir una remisión parcial o completa. El tratamiento puede ser continuado mientras el paciente muestre respuesta, siga beneficiándose o presente enfermedad estable, es decir, en ausencia de progresión aparente.

Si después de 4 ciclos, los valores hematológicos del paciente (por ejemplo, recuentos de plaquetas o recuento absoluto de neutrófilos), no han vuelto a niveles previos al tratamiento o si se produce la progresión de la enfermedad (el recuento de blastocitos

periféricos están aumentando o el conteo de blastos en la médula ósea están empeorando), se considerará que el paciente no está respondiendo al tratamiento y se deberá considerar las opciones terapéuticas alternativas a la decitabina.

No se recomienda el tratamiento previo, de rutina, para la prevención de las náuseas y los vómitos, pero puede administrarse en caso necesario.

Tratamiento de la mielosupresión y complicaciones relacionadas

La mielosupresión y los acontecimientos adversos relacionados con la mielosupresión (trombocitopenia, anemia, neutropenia y neutropenia febril) son frecuentes en los pacientes con LMA tratados y sin tratar. Las complicaciones de la mielosupresión comprenden infecciones y hemorragias. El tratamiento puede retrasarse a criterio del médico responsable si el paciente presenta complicaciones asociadas a mielosupresión, como las que se describen a continuación:

- Neutropenia febril (temperatura ≥ 38.5ºC y recuento absoluto de neutrófilos < 1.000/µl)
- Infección vírica, bacteriana o micótica activa (es decir, con necesidad de anti-infecciosos intravenosos o de tratamiento de soporte exhaustivo)
- Hemorragia (digestiva, genitourinaria, pulmonar con plaquetas < 25.000/µl o cualquier hemorragia que afecte al sistema nervioso central)

El tratamiento con decitabina podrá reanudarse una vez que estas afecciones hayan mejorado o se hayan estabilizado con el tratamiento adecuado (anti-infecciosos, transfusiones o factores de crecimiento).

En estudios clínicos, aproximadamente un tercio de los pacientes que recibieron decitabina, necesitaron un retraso de la dosis. No se recomienda la reducción de la dosis.

Población pediátrica

No se ha establecido la seguridad y la eficacia de decitabina en niños menores de 18 años. No hay datos disponibles.

Insuficiencia hepática

No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática. No se ha evaluado la necesidad de ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Si se produce un empeoramiento de la función hepática, los pacientes deben ser estrechamente vigilados

Insuficiencia renal

No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia renal. No se ha evaluado la necesidad de ajustar de la dosis en pacientes con insuficiencia renal

<u>Método de administración</u>

Decitabina es un fármaco citotóxico y se debe tener precaución al manipular y preparar Decitabina. Se deben aplicar los procedimientos para el manejo y la eliminación

adecuada de medicamentos antineoplásicos. Decitabina se administra mediante perfusión intravenosa. No se precisa un catéter venoso central.

Procedimiento de reconstitución

Decitabina para inyección debe reconstituirse asépticamente con 10 ml de agua estéril para inyección (USP). Después de la reconstitución, cada ml contiene aproximadamente 5 mg de decitabina a un pH de 6.7 a 7.3. Inmediatamente después de la reconstitución, la solución debe diluirse con 0.9% de cloruro de sodio inyectable, dextrosa al 5%, o solución inyectable de Lactato de Ringer hasta una concentración final de fármaco de 0.1 a 1 mg/ml. Salvo que se utilice dentro de los primeros 15 minutos después de reconstituido, la solución diluida debe prepararse utilizando fluidos para infusión (Dextrosa 5%, Cloruro de Sodio 0.9%, Lactato de Ringer entre 2 - 8°C) y almacenarse a una temperatura entre 2 a 8°C hasta un máximo de 7 horas antes de su administración.

Decitabina no se debe perfundir a través del mismo acceso/vía intravenosa con otros medicamentos.

Este medicamento es únicamente para un solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Los medicamentos parenterales deben ser inspeccionados visualmente para detectar partículas y decoloración antes de la administración, siempre que la solución y el contenedor lo permitan. No lo use si hay evidencia de partículas o decoloración.

Contraindicaciones

Conocida hipersensibilidad a la decitabina o alguno de los excipientes. Embarazo y lactancia.

Advertencias y precauciones especiales para su uso

Mielosupresión

La mielosupresión y sus complicaciones, incluidas las infecciones y las hemorragias que se producen en los pacientes con LMA, pueden empeorar con el tratamiento con decitabina. Por lo tanto, los pacientes están en mayor riesgo de infecciones graves (debido a cualquier patógeno, tales como infecciones bacterianas, fúngicas y virales), con desenlace fatal. Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de la infección y tratados con prontitud.

En estudios clínicos, la mayoría de los pacientes tenían mielosupresión de Grado 3/4 en el momento basal. Se observó empeoramiento de la mielosupresión en la mayoría de los pacientes con alteraciones de Grado 2 en el momento basal, y más frecuentemente que en pacientes con alteraciones de Grado 1 o 0 en el momento basal. La mielosupresión causada por decitabina es reversible. Se deben realizar hemogramas y recuentos de plaquetas periódicamente, cuando esté clínicamente indicado y antes de cada ciclo de tratamiento. En presencia de mielosupresión o sus

complicaciones, se puede interrumpir el tratamiento con decitabina y/o instaurar medidas de apoyo.

El tratamiento con decitabina se asocia con neutropenia y trombocitopenia. Después de la administración de la dosis recomendada para el primer ciclo, debe ajustarse el tratamiento para los ciclos posteriores. Los médicos deben considerar la necesidad de la institución temprana de factores de crecimiento y/o agentes antimicrobianos para la prevención o el tratamiento de infecciones en pacientes con SMD. La mielosupresión y el empeoramiento de la neutropenia pueden ocurrir con más frecuencia en el primer o segundo ciclo de tratamiento, y no necesariamente indican progresión del SMD subyacente.

Uso durante el Embarazo

Decitabina puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Según su mecanismo de acción, se espera que Decitabina produzca efectos reproductivos adversos. En estudios preclínicos en ratones y ratas, decitabina fue teratogénica, fetotóxica y embriotóxica. No existen estudios adecuados y bien controlados de decitabina en mujeres embarazadas. Si este medicamento se usa durante el embarazo o si una paciente queda embarazada mientras recibe este medicamento, debe informarse al paciente sobre el riesgo potencial para el feto. Se debe aconsejar a mujeres en edad fértil que eviten quedar embarazadas mientras toman Decitabina.

Uso en Mujeres en Edad Fértil

Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedar embarazadas mientras reciben Decitabina y durante 1 mes después de la finalización del tratamiento. A las mujeres en edad fértil se les debe aconsejar que usen anticonceptivos efectivos durante este tiempo. Según su mecanismo de acción, la Decitabina puede causar daño fetal si se usa durante el embarazo.

Uso en Hombres

Se debe aconsejar a los hombres que no engendren un hijo mientras reciben tratamiento con Decitabina, y durante 2 meses después de la finalización del tratamiento. Los hombres con parejas femeninas en edad fértil deben usar anticonceptivos efectivos durante este tiempo. Basado en su mecanismo de acción, Decitabina altera la síntesis del ADN y puede causar daño fetal.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) (incluyendo infiltrados pulmonares, neumonía organizativa y fibrosis pulmonar) sin signos de etiología infecciosa en pacientes que reciben decitabina. Se debe realizar una evaluación cuidadosa de los pacientes con un empeoramiento agudo o inexplicable de los síntomas pulmonares para excluir la EPI. Si se confirma la EPI, se debe iniciar el tratamiento apropiado.

Insuficiencia hepática

No se ha establecido el uso de decitabina en pacientes con insuficiencia hepática. Se recomienda precaución durante la administración de decitabina a pacientes con insuficiencia hepática y realizar monitoreos estrictos a estos pacientes.

Insuficiencia renal

El uso de decitabina en pacientes con insuficiencia renal grave no se ha estudiado. Se recomienda precaución durante la administración de decitabina a pacientes con insuficiencia renal grave (Aclaramiento de creatinina [CrCl] < 30 ml/min) y realizar monitoreos estrictos a estos pacientes.

Enfermedad cardiaca

Los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva grave o de cardiopatía clínicamente inestable fueron excluidos de los estudios clínicos y, por tanto, la seguridad ni la eficacia de decitabina no ha sido establecida en estos pacientes.

Excipientes

Este medicamento contiene 0.5 mmol de potasio por vial. Después de la dilución de la solución reconstituida para perfusión intravenosa, este medicamento contiene menos de 1 mmol (39 mg) de potasio por dosis, esto es esencialmente “libre de potasio”.

Este medicamento contiene 0,29 mmol de sodio por vial. Tras la dilución de la solución reconstituida para perfusión intravenosa, este medicamento contiene entre 0,6-6 mmol de sodio por dosis en función del volumen para perfusión de la dilución. Los pacientes que sigan una dieta con control del sodio deben tenerlo en cuenta.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han realizado estudios clínicos formales de interacciones farmacológicas con decitabina.

Existe la posibilidad de una interacción entre medicamentos con otros agentes que también se activan por fosforilación secuencial (a través de las actividades intracelulares de la fosfoquinasa) y/o que se metabolizan por enzimas implicadas en la inactivación de la decitabina (por ejemplo, citidina deaminasa). Por lo tanto, se debe tener precaución si estos medicamentos se combinan con decitabina.

Impacto de los medicamentos administrados de forma concomitante sobre decitabina

No se espera que se produzcan interacciones metabólicas mediadas por el citocromo P450 (CYP) dado que el metabolismo de la decitabina no está mediado por este sistema, sino por desaminación oxidativa.

Impacto de la decitabina sobre los medicamentos administrados de forma concomitante

Teniendo en cuenta su escasa unión a las proteínas plasmáticas *in vitro* (< 1 %), es improbable que la decitabina impida la unión a las proteínas plasmáticas de los medicamentos administrados de forma concomitante. Se ha demostrado que la decitabina es un inhibidor débil del transporte mediado por la P-gp *in vitro*, por lo que

no se espera que afecte a los medicamentos administrados concomitantemente cuyo transporte está mediado por la P-gp.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Mujeres en edad fértil/Anticoncepción en hombres y mujeres

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces y evitar quedar embarazadas durante el tratamiento con decitabina. No se conoce el período de tiempo después del tratamiento con decitabina donde es seguro para quedar en embarazo. Los hombres deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces y no deberían engendrar un hijo mientras están recibiendo decitabina, y durante los 3 meses siguientes a la finalización del tratamiento.

El uso de la decitabina con los anticonceptivos hormonales no ha sido estudiado.

Embarazo

No existen datos suficientes sobre la utilización de la decitabina en mujeres embarazadas. Los estudios han demostrado que la decitabina es teratogénico en ratas y ratones. El riesgo potencial en humanos es desconocido. Con base en los resultados de estudios en animales y su mecanismo de acción, decitabina no debe utilizarse durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen un método anticonceptivo eficaz. Si se utiliza decitabina durante el embarazo, o si la paciente queda embarazada mientras recibe este medicamento, la paciente debe ser informada del daño potencial para el feto.

Lactancia

No se sabe si la decitabina o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Decitabina está contraindicado durante la lactancia; Por lo tanto, si se requiere tratamiento con decitabina, en periodo de lactancia debe ser interrumpida.

Fertilidad

No hay datos disponibles sobre el efecto de la decitabina en la fertilidad en humanos. En estudios preclínicos realizados en animales, la decitabina afectó a la fertilidad masculina y fue mutágenico. Debido a la posibilidad de infertilidad como consecuencia de la terapia con decitabina, los hombres deben recibir asesoramiento sobre la conservación de espermatozoides y las mujeres en edad fértil deben recibir asesoramiento sobre la crio conservación de ovocitos antes de iniciar el tratamiento.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Decitabina puede tener una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Los pacientes deben ser informados que pueden experimentar efectos indeseables tales como la anemia durante el tratamiento. Por lo tanto, debe recomendarse precaución al conducir un carro o utilizar máquinas.

Reacciones adversas

Resumen del perfil de seguridad

Síndrome Mielodisplásico (SMD)

Reacciones adversas más frecuentes: neutropenia, trombocitopenia, anemia, fatiga, pirexia, náuseas, tos, petequias, estreñimiento, diarrea e hiperglucemia.

Reacciones Adversas Más frecuentes (≥ 1%) Que Dieron Como Resultado una Intervención Clínica en los Ensayos de Fase 3 en el Grupo con Decitabina:

- ***Interrupción:*** trombocitopenia, neutropenia, neumonía, infecciones complejas con Mycobacterium avium, paro cardiorrespiratorio, aumento de la bilirrubina en la sangre, hemorragia intracraneal, pruebas anormales de la función hepática.
- ***Retraso de la Dosis:*** neutropenia, edema pulmonar, fibrilación auricular, infección de la línea central, neutropenia febril.
- ***Reducción de la Dosis:*** neutropenia, trombocitopenia, anemia, letargia, edema, taquicardia, depresión, faringitis.

Discusión de la Información de Reacciones Adversas

Se estudió Decitabina en 3 estudios de grupo simple (N = 66, N = 98, N = 99) y 1 estudio controlado de cuidados paliativos (N = 83 Decitabina, N = 81 cuidados paliativos). Los datos que se describen a continuación reflejan la exposición a decitabina en 83 pacientes en el ensayo de SMD. En el ensayo, los pacientes recibieron 15 mg/m^2 por vía intravenosa cada 8 horas durante 3 días cada 6 semanas. La mediana de los ciclos de Decitabina fue de 3 (rango 0 a 9).

A continuación se presentan todos los eventos adversos independientemente de la causalidad que se presentaron en al menos el 5% de los pacientes en el grupo de Decitabina y a una tasa mayor que la del grupo de cuidados paliativos.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Neutropenia, Trombocitopenia, Anemia NEOM, Neutropenia febril, Leucopenia NEOM, Linfadenopatía, Trombocitemia.

Trastornos cardiacos: Edema pulmonar NEOM

Trastornos oculares: Visión borrosa

Trastornos gastrointestinal: Náuseas, Estreñimiento, Diarrea NEOM, Vómitos NEOM, Dolor abdominal NEOM, Petequias mucosas orales, Estomatitis, Dispepsia, Ascitis, Hemorragia gingival, Hemorroides, Heces blandas, Ulceración de la lengua, Disfagia, Trastorno oral de partes blandas NEOM, Úlceras labiales, Distensión abdominal, Dolor abdominal superior, Enfermedad de reflujo gastroesofágico, Glosodinia.

Trastornos generales y trastornos del sitio de la administración: Pirexia, Edema periférico, Rigores, Edema NEOM, Dolor NEOM, Letargo, Sensibilidad NEOM, Caída,

Malestar en el pecho, Pirexia intermitente, Malestar, Crepitaciones NEOM, Eritema en el sitio del catéter, Dolor en el sitio del catéter, Inflamación en el sitio de inyección.

Trastornos hepatobiliares: Hiperbilirrubinemia

Infecciones e infestaciones: Neumonía NEOM, Celulitis, Infección por cándida NEOM, Infección relacionada con el catéter, Infección del tracto urinario NEOM, Infección estafilocócica, Candidiasis oral, Sinusitis NEOM, Bacteriemia

Lesión, envenenamiento y complicaciones del procedimiento: Reacción a la transfusión, Abrasión NEOM,

Investigaciones: Soplo cardíaco NEOM, Aumento de la fosfatasa alcalina en sangre, Aumento de la aspartato aminotransferasa, Aumento de la urea en sangre, Aumento de la lactato deshidrogenasa en sangre, Disminución de la albúmina en sangre, Aumento del bicarbonato en sangre, Disminución del cloruro en sangre, Disminución total de la proteína, Disminución del bicarbonato en sangre, Disminución de la bilirrubina en sangre.

Trastornos del metabolismo y la nutrición: Hiperglucemia NEOM, Hipoalbuminemia, Hipomagnesemia, Hipopotasemia, Hiponatremia, Disminución del apetito NEOM, Anorexia, Hiperpotasemia, Deshidratación

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Artralgia, Dolor en las extremidades, Dolor de espalda, Dolor de la pared torácica, Malestar musculoesquelético, Mialgia

Trastornos del sistema nervioso: Dolor de cabeza, Mareos, Hipoestesia

Trastornos siquiátricos: Insomnio, Estado confusión, Ansiedad

Trastornos renales y urinarios: Disuria, Frecuencia urinaria

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Tos, Faringitis, Pulmones agrietados, Disminución de los ruidos respiratorios, Hipoxia, Estertores, Goteo posnasal

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Equimosis, Erupción NEOM, Eritema, Lesión de la piel NEOM, Prurito, Alopecia, Urticaria NEOM, Hinchazón facial

Trastornos vasculares: Petequias, Palidez, Hipotensión NEOM, Hematoma NEOM.

Discusión de Reacciones Adversas Clínicamente Importantes

En el ensayo controlado con Decitabina administrado a dosis de 15 mg/m^2, administrado mediante perfusión intravenosa continua durante 3 horas cada 8 horas durante 3 días, la incidencia más alta de eventos adversos de Grado 3 o Grado 4 en el grupo de Decitabina fue neutropenia (87%) , trombocitopenia (85%), neutropenia febril (23%) y leucopenia 22%). La supresión de la médula ósea fue la causa más frecuente de reducción de la dosis, retraso e interrupción. Seis pacientes tuvieron eventos fatales asociados con su enfermedad subyacente y mielosupresión (anemia, neutropenia y trombocitopenia) que se consideraron al menos posiblemente relacionados con el tratamiento con el fármaco. De los 83 pacientes tratados con

Decitabina, 8 interrumpieron permanentemente el tratamiento por eventos adversos; en comparación con 1 de 81 pacientes en el grupo de cuidados paliativos.

En un estudio de SMD de un solo grupo (N = 99), la dosis de Decitabina fue de 20 mg/m por vía intravenosa, infundida durante una hora diaria durante 5 días consecutivos de un ciclo de 4 semanas. A continuación se presentan todos los eventos adversos, independientemente de la causalidad que ocurrieron en al menos el 5% de los pacientes.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Anemia, Neutropenia Febril, Leucopenia, Neutropenia, Pancitopenia, Trombocitemia, Trombocitopenia

Trastornos cardiacos: Insuficiencia cardíaca congestiva, Taquicardia

Trastornos del oído y del laberinto: Dolor de oído

Trastornos gastrointestinales: Dolor abdominal, Dolor abdominal superior, Estreñimiento, Diarrea, Dispepsia, Disfagia, Enfermedad de reflujo gastroesofágico, Náuseas, Dolor oral, Estomatitis, Dolor dental, Vómito.

Trastornos generales y condiciones del sitio de administración: Astenia, Dolor en el pecho, Escalofríos, Fatiga, Inflamación de la mucosa, Edema, Edema periférico, Dolor, Pirexia,

Infecciones e infestaciones: Celulitis, Candidiasis oral, Neumonía, Sinusitis, Bacteriemia estafilocócica, Absceso dental, Infección del tracto respiratorio superior, Infección del tracto urinario

Lesión, envenenamiento y complicaciones del procedimiento: Contusión

Investigaciones: Bilirrubina en sangre elevada, Ruidos respiratorios anormales, Pérdida de peso

Trastornos del metabolismo y la nutrición: Anorexia, Disminución del apetito, Deshidratación, Hiperglucemia, Hipopotasemia, Hipomagnesemia

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Artralgia, Dolor de espalda, Dolor de huesos, Espasmos musculares, Debilidad muscular, Dolor musculoesquelético, Mialgia, Dolor en las extremidades.

Trastornos del sistema nervioso: Mareos, Dolor de cabeza,

Trastornos psiquiátricos: Ansiedad, Estado de confusión, Depresión, Insomnio.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Tos, Disnea, Epistaxis, Dolor faringolaríngeo, Derrame pleural, Congestión de los senos paranasales

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Piel seca, Equimosis, Eritema, Sudores nocturnos, Petequias, Prurito, Erupción cutánea, Lesiones cutáneas.

Trastornos vasculares: Hipertensión, Hipotensión

Discusión de Reacciones Adversas Clínicamente Importantes

En el estudio de un solo grupo (N = 99) cuando se administró Decitabina a 20 mg/m^2 intravenoso, infundido durante una hora diaria durante 5 días consecutivos, la incidencia más alta de eventos adversos de Grado 3 o Grado 4 fue neutropenia (37%), trombocitopenia (24%) y anemia (22%). Setenta y ocho por ciento de los pacientes presentaron retrasos en la dosis, la mediana de este retraso fue de 7 días y el mayor porcentaje de retrasos se debió a toxicidades hematológicas. Las toxicidades e infecciones hematológicas fueron las causas más frecuentes de retrasos en las dosis y de la interrupción. Ocho pacientes tuvieron eventos fatales debido a infección y/o sangrado (siete de los cuales ocurrieron en el entorno clínico de mielosupresión) que se consideraron, al menos, posiblemente relacionados con el tratamiento con el fármaco. Diecinueve de 99 pacientes interrumpieron permanentemente la terapia por eventos adversos.

No se detectó una diferencia general en seguridad entre pacientes> 65 años de edad y pacientes más jóvenes en estos ensayos de mielodisplasia. No se detectaron diferencias significativas de género en la seguridad o la eficacia. Los pacientes con disfunción renal o hepática no fueron estudiados. Hubo un número insuficiente de pacientes no caucásicos disponibles para sacar conclusiones en estos ensayos clínicos.

Los Eventos Adversos Graves que ocurrieron en pacientes que recibieron Decitabina independientemente de la causalidad, no se informaron previamente e incluyen:

- **Trastornos del sistema sanguíneo y linfático:** mielosupresión, esplenomegalia.
- **Trastornos Cardiacos:** infarto de miocardio, paro cardiorrespiratorio, miocardiopatía, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular.
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor gingival, hemorragia gastrointestinal superior.
- **Trastornos generales y condiciones en el sitio de administración:** dolor en el pecho, hemorragia en el sitio del catéter.
- **Trastornos hepatobiliares:** colecistitis.
- **Infecciones e infestaciones:** infección fúngica, sepsis, aspergilosis broncopulmonar, absceso peridiverticular, infección del tracto respiratorio, infección pulmonar por pseudomonas, infección del complejo Mycobacterium avium.
- **Lesión, Envenenamiento y Complicaciones del procedimiento**: dolor después del procedimiento, hemorragia después del procedimiento.
- **Trastornos del sistema nervioso:** hemorragia intracraneal.
- **Trastornos psiquiátricos:** cambios de estado mental.
- **Trastornos renales y urinarios**: insuficiencia renal, hemorragia uretral.
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** hemoptisis, infiltración pulmonar, embolia pulmonar, paro respiratorio, masa pulmonar.
- **Reacción alérgica:** Se ha reportado hipersensibilidad (reacción anafiláctica) a Decitabina en un ensayo de Fase 2.

Experiencia Postcomercialización

Las siguientes reacciones adversas se han identificado durante el uso posterior a la aprobación de Decitabina. Debido a que estas reacciones se informan voluntariamente de una población de tamaño indeterminado, no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Se han notificado casos de síndrome de Sweet (dermatosis neutrofílica febril aguda).

Leucemia mieloide aguda (LMA)

Las reacciones adversas a los medicamentos más comunes reportados (≥ 35%) son pirexia, anemia y trombocitopenia.

Las reacciones adversas de Grado 3/4 más frecuentes (≥ 20 %) incluyeron neumonía, trombocitopenia, neutropenia, neutropenia febril y anemia.

En los estudios clínicos, el 30% de los pacientes tratados con decitabina y el 25% de los pacientes tratados en el grupo comparador sufrieron efectos adversos con un resultado de muerte durante el tratamiento o dentro de los 30 días posteriores a la última dosis del medicamento del estudio.

En el grupo de tratamiento con decitabina, hubo una mayor incidencia de la interrupción del tratamiento debido a eventos adversos en mujeres que en hombres (43% frente a 32%).

Lista tabulada de reacciones adversas

Las reacciones adversas notificadas en 293 pacientes con LMA tratados con decitabina están resumidas en la Tabla 1. En la siguiente tabla se recogen los datos de los estudios clínicos en pacientes con LMA. Las reacciones adversas se enumeran por orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: Muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000). Desconocidas (la frecuencia no puede ser estimada a partir de los datos disponibles)

Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas a los medicamentos se presentan en orden decreciente de gravedad.

Tabla 1: Reacciones adversas al medicamento identificadas con decitabina

Sistema de Clasificación de Órganos	**Frecuencia (todos los grados)**	**Reacciones adversas al medicamento**	**Frecuencia**	
			Todos los grados [a] (%)	**Grados 3-4[a] (%)**
Infecciones e infestaciones	Muy frecuentes	Neumonía*	24	20
		Infecciones del tracto urinario*	15	7
		Todas las demás infecciones (viral, bacteriana, fúngica)*, b, c, d	63	39

	Frecuentes	Shock séptico *	6	4
		sepsis*	9	8
		sinusitis	3	1
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Muy frecuentes	Neutropenia febril*	34	32
		neutropenia*	32	30
		trombocitopenia*, e	41	38
		anemia	38	31
		leucopenia	20	18
	Desconocidas	pancitopenia*	< 1	< 1
Trastornos del sistema inmunológico	Frecuentes	hipersensibilidad, incluida reacción anafiláctica[f]	1	< 1
Trastornos del Sistema nervioso	Muy frecuentes	cefalea	16	1
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Muy frecuentes	epistaxis	14	2
Trastornos gastrointestinales	Muy frecuentes	diarrea	31	2
		vómito	18	1
		náusea	33	< 1
	Frecuentes	estomatitis	7	1
	Desconocidos	enterocolitis, incluyendo colitis nuetropénica, caecitis*	Desconocido	Desconocido
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Poco frecuentes	dermatosis neutrofílica febril aguda (síndrome de Sweet)	< 1	NA
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Muy frecuentes	pirexia	48	9

[a] Peor Grado según los Criterios Terminológicos Comunes para Acontecimientos Adversos del National Cancer Institute.
[b] Excluyendo neumonía, infección del tracto urinario, sepsis, shock séptico y la sinusitis.
[c] Los más frecuentes reportados en los estudios de "otras infecciones" DACO-016 fueron: el herpes oral, candidiasis oral, faringitis, infección del tracto respiratorio superior, celulitis, bronquitis, faringitis.
[d] Incluyendo enterocolitis infecciosa.
[e] Incluyendo hemorragia asociada con trombocitopenia, incluyendo casos fatales.
[f] Se incluyen los términos preferentes hipersensibilidad, hipersensibilidad al fármaco, reacción anafiláctica, shock anafiláctico, reacción anafilactoide, shock anafilactoide.
* Incluye reacciones con desenlace fatal.
NA = No aplica

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Reacciones adversas hematológicas

Las reacciones adversas hematológicas reportadas más frecuentemente asociadas al tratamiento con decitabina fueron neutropenia febril, trombocitopenia, neutropenia, anemia y leucopenia.

Se han reportado reacciones adversas graves relacionadas con hemorragias, algunas de las cuales tuvieron un desenlace mortal, como hemorragia en el sistema nervioso central (SNC; 2 %) y hemorragia digestiva (2 %), en el contexto de una trombocitopenia grave, en pacientes tratados con decitabina.

Las reacciones adversas hematológicas deben ser manejadas mediante controles periódicos con hemogramas completos y la administración precoz de tratamientos de apoyo según sea necesario. Los tratamientos de apoyo incluyen, administración de antibióticos profilácticos y/o apoyo del factor de crecimiento (por ejemplo, G-CSF) para la neutropenia y las transfusiones para la anemia o trombocitopenia según las directrices institucionales. Para situaciones en las que la administración de decitabina debe retrasarse, consulte la sección de posología y el método de administración.

Infecciones e infestaciones por reacciones adversas al medicamento

Las infecciones graves relacionadas con las reacciones adversas a los medicamentos, con resultados potencialmente fatales, tales como shock séptico, sepsis, neumonía y otras infecciones (virales, bacterianas y fúngicas) fueron reportadas en pacientes tratados con decitabina.

Trastornos gastrointestinales

Ocurrencias de enterocolitis, incluyendo la colitis neutropénica, caecitis han sido reportadas durante el tratamiento con decitabina. Enterocolitis puede dar lugar a complicaciones sépticas y puede ser asociado con desenlace fatal.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos.

Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial (incluidos los infiltrados pulmonares, la neumonía organizativa y la fibrosis pulmonar) sin signos de etiología infecciosa en pacientes que reciben decitabina.

Sobredosis

No hay experiencia directa de la sobredosis en humanos y no existe ningún antídoto específico. Sin embargo, datos de los primeros de estudios clínicos publicados en la literatura, con dosis superiores a 20 veces mayor que la dosis terapéutica actual, reportó una mayor incidencia de mielosupresión incluyendo neutropenia prolongada y trombocitopenia. La toxicidad es probable que se manifieste como exacerbaciones de reacciones adversas a los medicamentos, sobre todo mielosupresión. El tratamiento de la sobredosis debe ser de apoyo.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas

Mecanismo de acción

La decitabina (5-aza-2′-desoxicitidina) es un análogo de la citidina desoxinucleósida que inhibe de forma selectiva las metiltransferasas del ADN en dosis bajas, lo que produce la hipometilación de promotores génicos, que puede causar una reactivación de genes supresores tumorales, la inducción de diferenciación celular o la senescencia celular, seguida de la muerte celular programada.

Propiedades farmacocinéticas

Los parámetros de farmacocinética (FC) poblacional de decitabina fueron agrupados de 3 estudios clínicos realizados en 45 pacientes con LMA o síndrome mielodisplásico (SMD) que utilizaron el régimen de 5 días. En cada estudio, la decitabina FC se evaluó en el quinto día del primer ciclo de tratamiento.

Distribución

La farmacocinética de la decitabina después de la administración intravenosa en una perfusión de 1 hora fue descrita por un modelo lineal de dos compartimentos, que se caracteriza por la rápida eliminación del medicamento del compartimiento central y por la distribución relativamente lenta desde el compartimento periférico. En la siguiente Tabla 2, se muestran los parámetros farmacocinéticos de decitabina para un paciente típico (peso de 70 kg y superficie corporal de 1,73 m^2).

Tabla 2: Resumen del análisis de FC poblacional para un paciente típico tratado con infusiones diarias de 1 hora de decitabina 20 mg/m^2 durante 5 días cada 4 semanas

Parámetro [a]	**Valor teórico**	**IC del 95%**
C_{max} (ng/ml)	107	88.5 - 129
AUC_{cum} (ng.h/ml)	580	480 - 695
$t_{1/2}$ (min)	68.2	54.2 - 79.6
Vd_{ss} (L)	116	84.1 - 153
CL (L/h)	298	249 - 359

[a] El total de dosis por ciclo fue de 100 mg/m^2

Decitabina presenta una farmacocinética lineal y después de la perfusión intravenosa, las concentraciones en estado estacionario se alcanzan en el plazo de 0.5 horas. Basado sobre una simulación de modelos, los parámetros FC fueron independientes del tiempo (es decir, no cambiaron entre un ciclo y otro) y no se observó acumulación con este régimen posológico. La unión de decitabina a las proteínas plasmáticas es insignificante (<1 %). El Vd_{ss} de decitabina es amplio en los pacientes con cáncer, lo que indica la distribución en los tejidos periféricos. No hubo evidencia de dependencia de la edad, del aclaramiento de creatinina, de la bilirrubina total ni de la enfermedad.

Los parámetros farmacocinéticos se evaluaron en pacientes. Once pacientes recibieron 20 mg/m^2 con perfusión durante 1 hora por vía intravenosa (Opción 2 de tratamiento), catorce pacientes recibieron 15 mg/m^2 con perfusión durante 3 horas (Opción 1 de tratamiento). En la siguiente tabla se presentan los parámetros

farmacocinéticos. Los perfiles de tiempo de concentración plasmática después de la interrupción de la infusión mostraron una disminución biexponencial. El CL de decitabina fue mayor después de la Opción 2 de tratamiento. Con las dosis repetidas no hubo acumulación sistémica de decitabina ni ningún cambio en los parámetros farmacocinéticos. El análisis farmacocinético de la población (N = 35) mostró que el ABC acumulativa por ciclo para la Opción 2 de tratamiento fue 2,3 veces menor que el ABC acumulativa por ciclo después de la Opción 1 de tratamiento.

Tabla 3: Pámetros Farmacocinéticos Medios (CV% o IC 95%) de Decitabina

Dosis	C_{max} (ng/mL)	$ABC_{0-\infty}$ (ng.h/mL)	$T_{1/2}$ (h)	CL (L/h/m^2)	**ABC Acumulativa*** (ng·h/mL)**
15 mg/m^2 3h de perfusión cada 8 horas por 3 días (Opción 1)*	73.8 (66)	163 (62)	0.62(49)	125 (53)	1332 (1010-1730)
20mg/m^2 1h de perfusión diaria por 5 días (Opción 2)**	147(49)	115 (43)	0.54 (43)	210 (47)	570 (470-700)

*N=14, **N=11, ***N=35 ABC Acumulativa por ciclo

Biotransformación

Intracelularmente, decitabina es activada mediante fosforilación secuencial a través de las actividades de fosfoquinasa dando lugar al trifosfato correspondiente, que posteriormente es incorporado por la polimerasa del ADN. Los datos de metabolismo *in vitro* y los resultados del estudio de equilibrio de masas en el ser humano indicaron que el sistema del citocromo P450 no interviene en el metabolismo de decitabina. La vía principal de metabolismo es probable que sea la desaminación por la citidina desaminasa en el hígado, el riñón, el epitelio intestinal y la sangre. Los resultados del estudio de equilibrio de masas en el ser humano demostraron que la decitabina inalterada en plasma representaba aproximadamente el 2,4 % de la radiactividad total en el plasma. Los principales metabolitos circulantes se cree que no son farmacológicamente activos. La presencia de estos metabolitos en la orina, junto con el elevado aclaramiento corporal total y la baja excreción urinaria del medicamento intacto (~4 % de la dosis), indican que decitabina se metaboliza de forma apreciable *in vivo*. Los estudios *in vitro* revelan que la decitabina no inhibe ni induce las enzimas del CYP 450 en más de 20 veces la concentración plasmática máxima terapéutica observada (C_{max}). Por lo tanto, no se espera que se produzcan interacciones farmacológicas metabólicas mediadas por el CYP y es poco probable que decitabina interaccione con medicamentos metabolizados por estas vías. Además, los datos *in vitro* indican que decitabina es un mal sustrato de la P-gp.

Eliminación

La eliminación plasmática media después de la administración intravenosa en sujetos con cáncer fue > 200 l/h, observándose una moderada variabilidad interindividual (el Coeficiente de variación [CV] es aproximadamente del 50 %). La excreción del medicamento intacto parece tener solo un rol menor en la eliminación de decitabina.

Los resultados de un estudio de equilibrio de masas con ^{14}C-decitabina radiactiva en pacientes con cáncer mostraron que el 90 % de la dosis administrada de decitabina (medicamento intacto en un 4 %) se excreta en la orina.

Información adicional sobre poblaciones especiales

Los efectos de la insuficiencia renal o hepática, el sexo, la edad ni la raza sobre la farmacocinética de decitabina no se han estudiado formalmente. La información sobre las poblaciones especiales se derivada a partir de los datos farmacocinéticos de los 3 estudios citados anteriormente y de un estudio en Fase I realizado en sujetos con SMD (N = 14; 15 mg/m^2 x 3 horas cada 8 horas x 3 días).

Pacientes de edad avanzada

El análisis de farmacocinética poblacional demostró que la farmacocinética de la decitabina no depende de la edad (intervalo de edad estudiado de 40 a 87 años; mediana de 70 años).

Género

El análisis de farmacocinética poblacional de decitabina no mostró ninguna diferencia clínica significativa entre hombres y mujeres.

Raza

La mayoría de los pacientes estudiados eran caucásicos. Sin embargo, el análisis de farmacocinética poblacional de decitabina indicó que la raza no tiene un afecto aparente en la exposición a decitabina.

Insuficiencia hepática

La farmacocinética de la decitabina no se ha estudiado formalmente en pacientes con insuficiencia hepática. Los resultados de un estudio de equilibrio de masas en el ser humano y los experimentos *in vitro* mencionados anteriormente indican que es improbable que las enzimas del CYP intervengan en el metabolismo de decitabina. Además, los datos limitados obtenidos en el análisis de farmacocinética poblacional indicaron que no existe dependencia significativa de ningún parámetro FC de la concentración de bilirrubina total a pesar de una amplia variedad de niveles de bilirrubina total. Por lo tanto, no es probable que la exposición a decitabina se vea afectada en los pacientes con deterioro de la función hepática.

Insuficiencia renal

La farmacocinética de la decitabina no se ha estudiado formalmente en pacientes con insuficiencia renal. El análisis de farmacocinética poblacional realizado con los datos limitados de decitabina disponibles indicó que no existe dependencia significativa de los parámetros FC del aclaramiento de creatinina normalizado, un indicador de la función

renal. Por lo tanto, no es probable que la exposición a decitabina se vea afectada en los pacientes con deterioro de la función renal.

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA

Mantener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento y Vida útil:

Almacenar a temperatura inferior a 30 °C en su envase y empaque original.

Los viales sin abrir de decitabina para inyección son estables hasta la fecha indicada en el envase cuando se almacena en el envase original.

Solución reconstituida: Salvo que se utilice dentro de los primeros 15 minutos después de reconstituido, la solución diluida debe prepararse utilizando fluidos para infusión (Dextrosa 5%, Cloruro de Sodio 0.9%, Lactato de Ringer entre 2 - 8°C) y almacenarse a una temperatura entre 2 a 8°C hasta un máximo de 7 horas antes de su administración.

Formas farmacéuticas y empaques disponibles

Forma farmacéutica: Polvo liofilizado para inyección

Empaque: Un vial por caja

Fabricado por:
Dr. REDDY'S LABORATORIES LTD.,
Plot Nos. P1 to P9 Phase III, VSEZ,
Duvvada, Visakhapatnam - 530 046,
A.P., INDIA.

TITULAR DE REGISTRO

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills,
Hyderabad - 500034
Telangana, India.

Versión: Octubre 2017 (2)